골밀도 검사 안내

DEXA 골밀도 검사는 적은 양의 X선으로 허리뼈(요추 L1~L4)와 엉덩이뼈(대퇴골 경부)의 뼈 강도를 재서 골다공증을 일찍 진단하는 표준 검사입니다.

검사 한눈에 보기

소요 시간	칼슘제	금식	방사선량
10~15 분	**24h** 전부터 중단	**불필요** 평소대로 식사	**1/10** 흉부 X-ray의

측정 부위와 검사 자세



무릎 쿠션 위에서 10~15분 누운 자세

항목	내용
측정 부위	**허리뼈(요추 L1~L4)**와 **엉덩이뼈 윗부분(대퇴골 경부)**을 잽니다.
검사 자세	무릎을 쿠션 위에 올리고 반듯이 누운 채 10~15분 움직이지 않습니다.
결과 판정	척추와 고관절 중 **더 낮은 쪽** 점수로 판정합니다.

검사 전·당일 체크리스트

검사 전 피할 것

- **칼슘제·종합비타민 24시간 중단** — 척추 영상에 비쳐 결과 왜곡
- **위장조영(바륨) 후 1~2주 회피** — 남은 조영제로 측정값 흐림
- **같은 날 CT 조영제 검사 금지**
- **임신 가능성 미리 알리기** — X-선 노출 평가

검사 당일 준비

- **편한 옷차림** — 금속 단추·지퍼·와이어 브래지어 피하기
- **금속 액세서리 제거** — 목걸이·허리띠·열쇠
- **평소 복용약 그대로** — 혈압·갑상선약은 끊지 않습니다
- **인공관절·척추 수술력 알리기**

권고 대상자와 결과 해석 (T점수)

이런 분께 권고됩니다

- **65세 이상 여성, 70세 이상 남성**
- **폐경 후 여성** — 저체중·가족력·흡연 시 65세 이전
- **장기 스테로이드 복용** — 3개월 이상
- **가벼운 외상으로 골절 경험**
- **갑상선항진증·만성 신질환**

T점수	판정	그다음
−1.0 이상	정상	2~5년 간격으로 추적
−1.0 미만 ~ −2.5 초과	골감소증	생활 관리 + 1~2년 뒤 재검. **골절 위험도를 계산해 높으면 약을 검토**합니다.
−2.5 이하	골다공증	**약물 치료 시작**

요추는 적절한 L1~L4의 평균으로 판단합니다. 골절·퇴행성 변화 등 명확한 사유가 있는 부위만 제외하고 최소 2부위가 필요합니다. 낮은 두 값이나 척추 한 개만 골라 진단하지 않습니다.
아산 28회 연수강좌 — 최신 보험기준을 반영한 골다공증 진단과 치료 실전(김범준)

급격한 체중 감소·과도한 운동·40세 이전 난소기능 저하를 알려 주세요. 시상하부성 무월경이 6개월 이상이면 골밀도 평가가 필요합니다.
아산 28회 연수강좌 — 월경이 불규칙한 환자, 무엇을 확인해야 하나?(이사라)

폐경 전 여성과 50세 미만 남성은 다른 기준(Z점수)으로 봅니다. 결과는 진료 때 설명해 드립니다.

함께 보기 — 진료실에서 보신 설명 자료 「골다공증 환자교육」 edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/osteoporosis/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한골대사학회 골다공증 진료지침 2024 · ISCD Official Positions · NOF Clinician's Guide · 세계보건기구 FRAX

본 자료는 일반적 안내입니다. 개별 위험 인자, 동반 질환, 검사 동반 여부에 따라 준비법이 달라질 수 있습니다.

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/imaging/bone-density-prep/